

Asignatura: Salud del niño, niña y adolescente
LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Guía para el ESTUDIANTE



ATENCIÓN INTEGRAL DEL LACTANTE / PRE ESCOLAR/ESCOLAR/ADOLESCENTE

-Contenidos: Atención integral del lactante niño/niña y adolescente

-Fecha : 15 y 17 de abril 2026

Objetivo general:

- Abordar la consulta integral de los niños y niñas menores de 2 años (Lactante), preescolar/escolar y adolescentes.

Objetivos específicos

- Realizar un correcto examen físico del lactante, pre escolar escolar y adolescente, en este reconocer particularidades, estadios de Tanner y variantes de la pubertad.
- Realizar una correcta evaluación de los datos antropométricos (peso, talla y PC) según la edad del paciente
- Realizar toma de agudeza visual en preescolares, escolares y adolescentes y saber derivar a especialista según necesidad.
- Recomendar correcto cepillado de dientes e higiene bucal
- Realizar correctamente la toma de Presión Arterial

Bibliografía general

- **Utilizar la bibliografía indicada en el seminario de atención integral del lactante para resolver la guía de lectura dirigida.**
- Guía de Salud Bucal Infantil para pediatras. Asociación latinoamericana de odontopediatría disponible en:
<https://backup.revistaodontopediatria.org/publicaciones/Guias/Guia-de-salud-bucal-infantil-para-pediatras-Web.pdf>
- Boggiano E, Breitman F, Andrade M. Manual para la supervisión de la Salud de niños , niñas y adolescentes. Manual abreviado. Buenos Aires: Fundación sociedad Argentina de Pediatría; 2010
- Visintin, P. Importancia de la visión en la infancia. PRONAP 2015; Módulo 1 Cap. 1, (página **22 a 26**)
- Control Oftalmológico previo al inicio escolar. SAP/ SAOI.Febrero 2023
https://saoi.org.ar/wp-content/uploads/2023/03/documentos_control-oftalmologico-previo-al-inicio-escolar-326-2.pdf
- Interpretación y uso de las nuevas tablas de referencia de presión arterial para niños, niñas y adolescentes PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR(PROANE) Enero 2020. Disponible en:
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2021-04/interpretacion-uso-nuevas-tablas-referencia-de-presion-arterial-prosane-2020.pdf>
- Técnicas de medición para la toma de peso y de altura Disponible en
https://iestpcbiblioteca.weebly.com/uploads/5/5/8/6/55866971/medicion_peso_talla.pdf
- Gacitúa María Victoria. Consenso de escoliosis idiopática del adolescente. SAP Arch Argent Pediatr 2016;114(6):**587-588**. Disponible en:
<https://aaot.org.ar/wp-content/uploads/2023/06/Arch-Argent-Pediatr-2016-114-6-585.pdf>
- Video realizado por UA sobre toma de TA y percentilos de TA. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1sipGTnyF6td3pW45LiR_rNVR46HSKMZ/view?usp=drive_link
- Video de técnica de cepillado. Disponible en:
<https://youtu.be/tx0YPpKZtfU?si=S6fTMXnAL2kQYUT>
https://www.youtube.com/watch?v=BxQD-Hm_Q9Y
- Video realizado por la UA sobre evaluación de Agudeza visual subido al campus.

GUIA DE LECTURA DIRIGIDA PARA EL ESTUDIANTE

1. ¿En qué consiste el examen clínico integral en el control de salud del lactante, pre escolar, escolar y adolescente y que aspectos se evalúan ? ¿Qué edades comprende un lactante? ¿Cuál es la periodicidad de los controles de salud?
2. ¿Cuál es la importancia de la evaluación del desarrollo infantil? ¿Qué significa PRUNAPE?
3. ¿Cuáles son las pautas de alarma del examen físico y cual es su conducta según edad?
4. Cual es el objetivo de la Maniobra de Adams, explique cómo realizarla
5. ¿Cómo se realiza la técnica de toma de peso para un lactante, pre, escolar, escolar y adolescente ?
6. ¿Cómo se realiza la técnica de toma de longitud corporal en el lactante, preescolar, escolar y adolescente?
7. ¿Cómo se realiza la toma de perímetro cefálico en el lactante?
- 8.¿Cuál es la técnica de evaluación de la agudeza visual en pre escolar/escolar y adolescente? Cuando se deriva al oftalmólogo?
9. ¿Cual es la técnica adecuada de toma de TA? ¿A partir de qué edad se realiza la toma?
- 10.¿Cuál es la técnica de cepillado de dientes correcta? ¿Cuándo se deriva al odontopediatra?

Estudiantes:

- **Traer la guía de lectura resuelta y estudiada. Al igual que los contenidos del seminario**
- **Traer Impreso los checklist de este LHC**
- **Traer guantes**

Realizar examen físico completo del lactante, preescolar, escolar y adolescente utilizando la lista de cotejo.

Lista de cotejo: Examen físico del lactante/preescolar/adolescente		Si	No
1	Saluda.		
2	Se presenta.		
3	Pregunta el nombre del paciente. En los adolescentes pregunta cómo quiere que lo llame Desea realizar consulta solo o acompañado > de 13 años		
4	Realiza lavado de manos.		
5	Desviste al paciente de manera respetuosa, teniendo en cuenta la edad y los tiempos de la consulta.		
6	Pide permiso para iniciar el examen físico		
7	Dice en voz alta que realizará el examen físico de forma cefalo caudal		
8	Dice en voz alta que inspecciona el estado general del paciente.		
9	Realiza evaluación de todos los signos vitales. FC- FR- T°-Sat O2		
10	Dice y realiza en voz alta que evalúa la forma del cráneo Cuero cabelludo (contextura, distribución, color, si existe pediculosis, lesiones, etc en preescolar/adolescentes)		
11	Dice en voz alta que evalúa la fontanela anterior (en lactante).		
12	Dice en voz alta que evalúa fontanela posterior (en lactante)		
13	Dice en voz alta que evalúa facie.		
14	Dice y realiza en voz alta que evalúa piel y mucosas (normocoloreadas, normohidratada, si tiene presencia de nevus, manchas, Petequias, etc) Color de piel: Palidez, Ictericia		
15	Dice y realiza en voz alta que evalúa Globos oculares, asimetrías, opacidades, coloración iris, pupilas, estrabismo		
16	Dice en voz alta que evalúa fijación de la mirada.		
17	Realiza reflejo rojo. Opacidades.(en lactante)		
18	Dice en voz alta que evalúa anatomía de pabellón auricular, evalúa implantación de pabellón auricular (implantación baja: asociado a cromosomopatías en lactantes)		
19	Realiza otoscopia en cada oído.		
20	Examina nariz y fosas nasales		
21	Dice en voz alta que evalúa la presencia de dientes y características de los mismos. Caries u otras lesiones en la boca.		
22	Dice en voz alta que evalúa el frenillo sublingual (en lactantes).		

23	Dice que evalúa cuello Ej: ganglios (tiroides en adolescentes).		
24	Dice y realiza evaluación de espacio supraclavicular		
25	Dice y realiza la Inspección del tórax, evalúa forma y mecánica ventilatoria		
26	Realiza y dice en voz alta auscultación pulmonar anterior simétrica y comparativa.		
27	Realiza y dice en voz alta auscultación pulmonar posterior simétrica y comparativa		
28	Realiza y dice en voz alta auscultación de la región lateral del tórax.		
29	Realiza y dice en voz alta que auscultación del aparato cardiovascular en 4 focos (los localiza mientras realiza la maniobra de auscultación)		
30	Realiza y dice en voz alta que toma pulsos de forma simétrica y comparativa. Debe de realizar todos los pulsos. En caso de RN y lactantes puede mencionar que si existe asimetría entre pulsos braquiales y femorales asociada a coartación de aorta.		
31	Realiza y dice en voz alta Inspección abdominal		
32	Realiza y dice en voz alta auscultación abdominal para determinar presencia de ruidos hidroaéreos.(aumentados, normales o disminuidos)		
33	Realiza y dice en voz alta la palpación superficial de abdomen		
34	Realiza y dice en voz alta la palpación profunda de abdomen		
35	Realiza la maniobra de palpación de hígado		
36	Realiza la maniobra de palpación del bazo		
37	Realiza la maniobra de palpación en búsqueda de masas profundas y peloteo renal.		
38	Realiza percusión abdominal		
39	Dice en voz alta y evalúa genitales femeninos: presencia de labios mayores,labios menores. Sinequias vulvares,Presencia de Capuchon del clitoris		
40	Dice en voz alta y evalúa genitales masculinos: presencia de pene y testículos, ubicación de uretra. Epispadias o Hipospadias, Testículos en bolsa. Presencia de hidrocele, diagnóstico diferencial con hernia inguinal. Transiluminación, puede realizarla		
41	Dice que calcula estadios de Tanner (en adolescentes)		
42	Dice en voz alta que evalúa Aparato osteoarticular: presencia de extremidades y dedos (en recién nacidos).		
43	Realiza y dice en voz alta que evalúa pliegues de miembros inferiores por delante y por detrás en lactantes		
44	Evalúa simetría de longitud de miembros inferiores.		
45	Realiza Signo de Galeazzi en lactantes		
46	Realiza Maniobra de Ortolani y Barlow en lactantes		

47	Dice en voz alta que evalúa Aparato osteoarticular:(preescolar, escolar y adolescente) Evalúa la columna: con el paciente de espalda, se debe observar • Nivel de los hombros. • Nivel de las escápulas. • Nivel de la pelvis.		
48	Dice que realiza la Maniobra de Adams (a partir de preescolar, escolar y adolescentes)		
49	Dice que evalúa rodillas, genu valgo, genu varo (según la edad que corresponda)		
50	Dice que evalúa pies, pie plano (según la edad que corresponda)		
51	Dice en voz alta que realiza examen neurológico (esto no se evaluará en este examen, solo mencionar este punto)		
52	Dice en voz alta que evalúa desarrollo en sus 4 áreas (personal- social, lenguaje, motricidad fina y gruesa hasta los 6 años)		
53	Dice que realiza toma de peso y percentila		
54	Dice que realiza toma de talla y percentila		
55	Dice que realiza toma el perímetro cefálico en menores de 3 años y percentila		
56	Dice que realiza el cálculo del IMC y percentila		
57	Dice que realiza la toma de TA (en mayores de 3 años) y percentila		
58	Dice y evalúa la agudeza visual con la tabla correspondiente a su edad. Comunica resultado de cada ojo y si debe realizar alguna derivación		
59	Se Comunica amablemente y anota los datos recabados en la historia clínica		

Estadios de Tanner : Bibliografía: Libro verde (pág: 115 a 120)

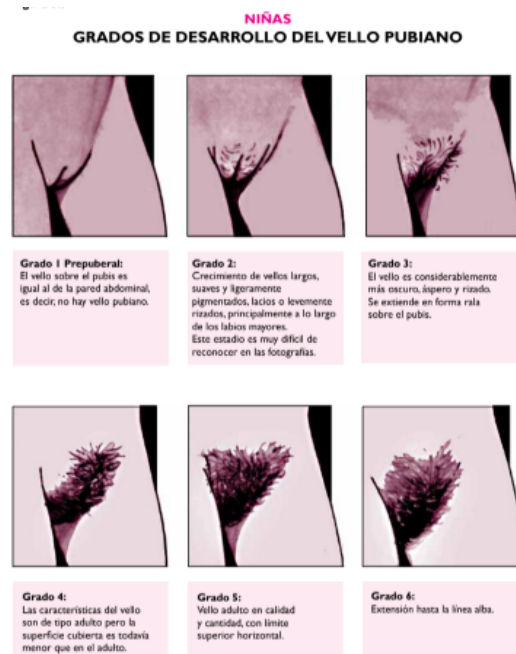
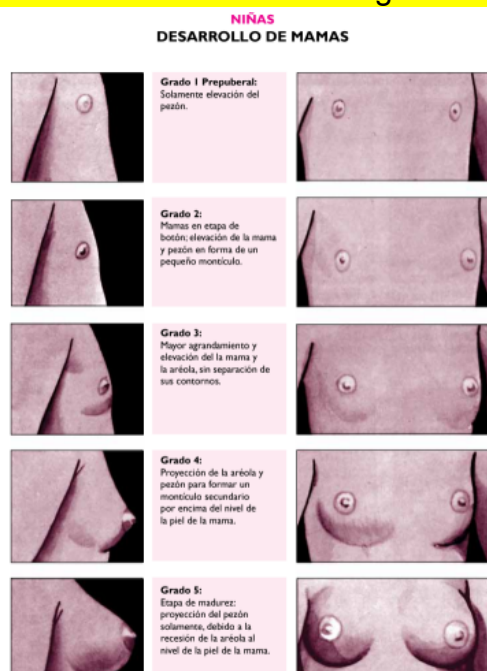
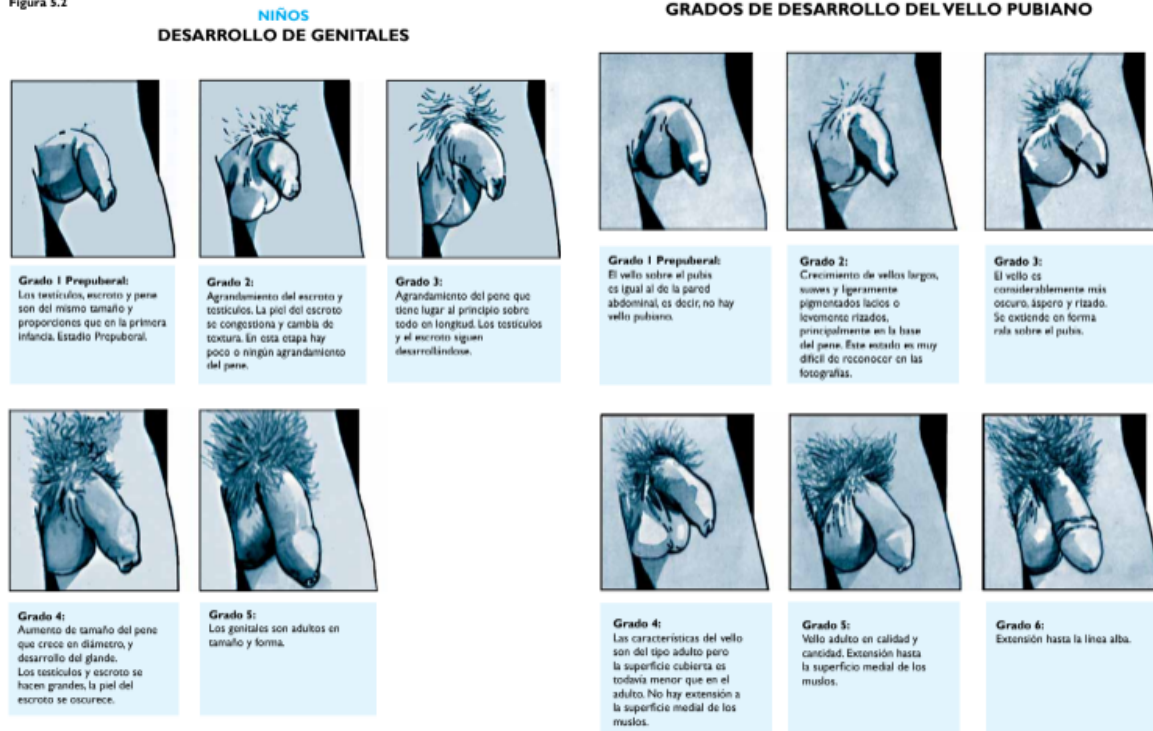


Figura 5.2



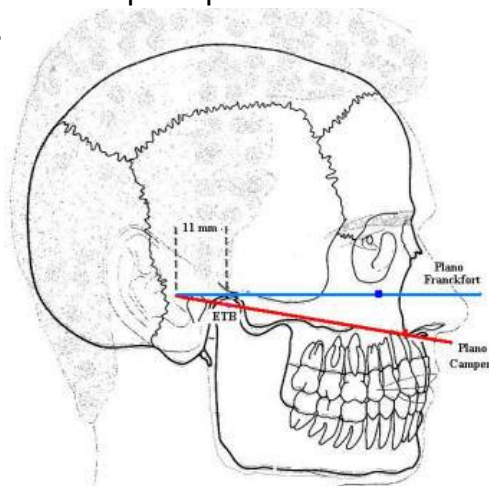
Realizar una correcta medición de peso, talla y perímetro cefálico en el lactante y peso y talla en el niño/a mayor con simulador siguiendo los check list

	CHECK LIST PESO BALANZA DE LACTANTE	SI	NO
1	Realiza correcto lavado de manos antes de examinar al paciente		
2	Reconoce cuál balanza utilizar para lactante y cómo colocarlo según tenga o no sedestación		
3	Verificar qué la balanza está calibrada en cero antes de apoyar al lactante		
4	Preguntar peso anterior a la madre o buscar en la historia clínica para colocar ese peso en la balanza y avanzar desde ahí		
5	Colocar al lactante desnudo en el centro de la balanza sin qué se agarre de nada		
6	Colocar la pesa de kilos (inferior) en el número qué corresponda e ir avanzando hacia la derecha si es necesario para lograr el equilibrio.		
7	Avanzar hacia la derecha con la pesa más pequeña de gramos (superior) hasta qué quede nivelado en el centro, estando en equilibrio.		
8	Registra el peso y percentila		

	CHECK LIST TALLA CON PEDIÓMETRO	SI	NO
1	Coloca al niño en decúbito supino hasta los 2 años		
2	La cabeza debe estar libre de cualquier objeto que interfiera en la medición (colitas, hebillas, etc)		
3	Se apoya sobre una superficie horizontal dura con regla graduada en milímetros		
4	Fija una superficie vertical en el extremo de la cabeza en plano paralelo, donde comienza la graduación (con ayudante)		
5	Colocar superficie móvil en el extremo distal con los pies descalzos en ángulo de 90°		
6	lee la talla, registra y percentila		

	CHECK LIST PERIMETRO CEFALICO	SI	NO
1	Usar una cinta inextensible		
2	La cabeza debe estar libre de cualquier objeto que interfiera en la medición (colitas, hebillas, etc)		
3	Colocar al paciente en decúbito supino , acostado en la camilla		
4	Colocar la cinta alrededor de la cabeza paralela al plano de Frankfurt. <i>(línea imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo-parte superior del orificio de la oreja), hacia la base de la órbita)</i> Ubicando el perímetro máximo de la cabeza, utilizando como referencia el punto máximo de occipucio y la glabella (en el entrecejo) Ejerciendo leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel y así tener un registro más fidedigno		
5	Registra el valor y percentilar en la curva de perímetro cefálico según edad		

COMENTARIO: El plano de Frankfurt pasa por los meatos auditivos externos y los bordes inferiores de las órbitas



CHECKLIST de PESO EN POSICIÓN DE PIE		Si	No
1	Constata que la balanza esté bien calibrada (verificar que ambas pesas de la balanza se encuentren en cero y la báscula esté en equilibrio)		
2	Antes de subir en la balanza constata que el paciente se encuentre con ropa interior y descalzo.		
3	Coloca al niño sobre el centro de la plataforma de pie		
4	Constata que el niño tenga los miembros superiores a los lados del cuerpo sin nada que los obstruya, ni donde se apoyen / constata este quieto		
5	Desliza la pesa inferior de kg hacia la derecha hasta que la flecha de la palanca se va hacia abajo y la posiciona en el lugar anterior		
6	Desliza la pesa superior de gramos hacia la derecha hasta que la flecha quede en equilibrio		
7	Toma peso y registra para luego percentilar.		

CHECKLIST de toma de TALLA DE PIE (estadímetro)		SI	No
1	Constata que el niño esté descalzo y sin ningún elemento en el cabello		
2	La cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la pared bajo la línea de la cinta del estadímetro. Los brazos deben colgar libres a los costados del cuerpo.		
3	Sostiene la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo para que el plano de Frankfurt (<i>línea imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo-parte superior del orificio de la oreja, hacia la base de la órbita</i>) quede paralelo al piso		
4	Pide al niño que inspire y vigila que no se ponga en puntillas. Colocando sus manos en las rodillas, las piernas rectas, talones juntos y puntas separadas (pies formen ángulo de 45 grados)		
5	Desliza la escuadra del estadímetro de arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza del niño, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello.		
6	Realiza la lectura hasta el último milímetro		
7	Toma talla y registra para luego percentilar.		

Realizar **Examen visual** general en el niño, niña y adolescente: inspección general, realización de reflejos (corneal, reflejo rojo) y Agudeza visual. Utilice los checklist.

La regla práctica es: AV = edad x 2

Nacimiento 1/20
1 año 2/10 a 4/10
2 años 4/10 a 6/10
3 años 6/10 a 8/10
4 años 8/10 a 10/10
6 años 10/10

CHECKLIST de toma de Agudeza VISUAL		SI	NO
1	Saluda y se presenta		
2	Pregunta nombre del/la paciente		
3	Pregunta si tiene alguna dificultad para ver o si utiliza anteojos		
4	Pregunta sobre antecedentes personales y familiares de alteraciones visuales y factores de riesgo.		
5	Pregunta si sabe leer o si conoce las letras del abecedario		
6	Realiza inspección general visual, buscando opacidades , estrabismo, etc.		
7	Explica al paciente cómo va a realizar la prueba de agudeza visual: taparse un ojo sin comprimir y nombrar la imagen que se señala. Luego repite con el otro ojo los mismo pasos		
8	Selecciona la tabla adecuada para evaluar AV según la edad del paciente (3 a 5 años optotipos del Lighthouse (manzana, paraguas) y mayores de 5 años la prueba es la E de Snellen. Niños más grandes carteles con letras si saben leer		
9	Ubica correctamente al paciente a la distancia sugerida para cada cartel (3 mt)		
10	Sabe cuál es el valor de la AV esperada normal según la edad del paciente, según tabla.		
11	Realiza la agudeza visual de cada ojo por separado, señalando de a una letra por fila desde la más grande a la más chica.		
12	Registra por escrito hasta la línea que haya podido identificar tanto en Ojo Izquierdo (OI) y Ojo Derecho (OD). Luego comunica		
13	Sabe cuándo es necesario realizar interconsulta con el oftalmólogo (si la AV no es la esperada para la edad o si existe una diferencia de 2 puntos entre un ojo y el otro)		

REALIZAR JUNTO AL CHECKLIST EL CORRECTO CEPILLADO DE DIENTES EN LOS SIMULADORES.

	LAVADO DE DIENTES	SI	NO
1	Recomienda inicio de cepillado al erupcionar el primer diente		
2	Recomienda utilizar cepillo de cerdas suaves		
3	Se recomienda cepillar dos veces al día Menores de 3 años: con una pasta que contenga al menos 1000 ppm de flúor en cantidad granito de arroz o al ras del cepillo. En mayores de 3 años con una pasta que contenga entre 1000 y 1450 ppm de flúor en cantidad del tamaño de una arveja o transversal al cepillo		
4	La pasta de dientes, debe ser siempre proporcionada por un adulto responsable y luego guardada fuera del alcance de niños y niñas.		
5	Recomienda Sujetar la cabeza del niño, levantar el labio superior y cepillar horizontalmente la unión entre encías y dientes		
6	LACTANTE Y PREESCOLAR: Realizar Cepillado Con los dientes juntos, en círculo, abarcando desde el borde de la encía del diente superior al diente inferior, con el cepillo en un ángulo de 90° (Técnica de cepillado circular de Fones)		
7	La limpieza de la cara interna se realiza con el cepillo lo más vertical posible y movimientos en zig-zag		
8	ESCOLAR Y ADOLESCENTE: Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, tanto cara interna como externa, con el cepillo en ángulo de 45° (Técnica de Bass/Stillman)		
9	Continuar con el cepillado de las superficies de masticación de atrás hacia adelante en dentadura superior e inferior		
10	Cepillar también la lengua con movimientos suaves de arrastre, de atrás hacia adelante.		
11	Se estima una duración aproximada de 2 minutos.		
12	Escupir el exceso de pasta, pero recomienda no enjuagar		
13	Recomendar el uso del hilo dental a partir de los 3 años de edad (cuando se cierran los espacios entre los molares), una vez al día.		
14	Recomendar repasar el cepillado nocturno por un adulto hasta los 8 a 10 años		
15	Recomendar la primera visita al odontopediatra como máximo antes del primer año de vida, lo ideal al salir el primer diente.		

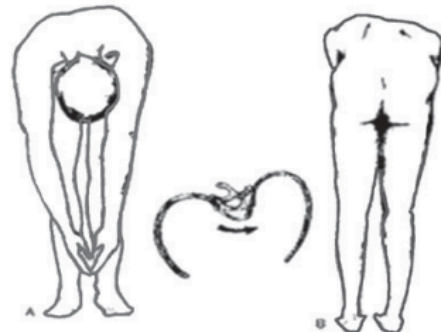
- Realizar una correcta **toma de TA** entre estudiantes guiándose con el check list.
- Realizar una correcta técnica para evaluar **Maniobra de Adams** entre estudiantes.

CHECKLIST de toma de Tensión Arterial		SI	NO
1	Realiza lavado de manos		
2	Ubica al paciente en posición sentado en ambiente confortable con su brazo derecho apoyado sobre la camilla o mesa.		
3	Dice que debe constatar reposo de al menos 5 minutos previo a la toma de TA .Constata previamente variables como ambiente tranquilo, temperatura agradable,etc		
4	Dice que el manguito debe cubrir el 80% del contorno del brazo y $\frac{2}{3}$ del largo del brazo desnudo, sin ropa		
5	Dice que el manguito se ubica ajustado 2 cm sobre el pliegue del codo y se lo coloca en el brazo a la altura del corazón		
6	Coloca el estetoscopio en el espacio entre el pliegue del codo y el manguito sobre el latido arterial.		
7	Coloca el manómetro a la altura de los ojos del observador.		
8	Insufla el mango en forma rápida hasta 20 o 30 mmHg por encima de la presión necesaria para ocluir totalmente la arteria braquial y así se deja de auscultar el latido.		
9	Desinfla lentamente de 2 a 3 mmHg por segundo y mientras se ausculta la arteria braquial.		
10	Indica qué la PA sistólica corresponde al primer ruido audible (Korotkov 1).y qué la PA diastólica corresponde al valor obtenido cuando el sonido desaparece en su totalidad (K 5)		
11	Dice qué deben realizarse por lo menos 3 tomas con un intervalo de 1 o 2 minutos entre las mismas.		
12	Dice que el valor de PA final será el resultado del promedio de las lecturas realizadas.		
13	Registra los valores en la hoja utilizando adecuada unidad de medida. (mmHg)		
14	Indica realización de percentiles con tabla adecuada según sexo, edad y talla		

	CHECKLIST MANIOBRA DE ADAMS	SI	NO
1	Constata que el paciente esté de pie, descalzo, con las piernas extendidas y la espalda descubierta y accesible al examinador con su postura habitual y sin correcciones		
2	Se coloca por detrás del paciente		
3	Le indica que se incline hacia adelante, con la cabeza lo más descendida posible sin flexionar las rodillas hasta que los hombros queden a la altura de las caderas mientras mantiene los brazos extendidos hacia abajo y las palmas juntas		
4	Evalúa la presencia de giba (rotación vertebral). La maniobra es positiva cuando la giba está presente (Adams positivo) y negativa cuando está ausente (Adams negativo).		
5	Le dice que se levante lentamente y se vista		



FIGURA 2. Maniobra de Adams



Maniobra de Adams: paciente inclinado hacia adelante, con la cabeza lo más descendida posible (mirando al piso) sin flexionar las rodillas hasta que los hombros queden a la altura de las caderas mientras mantiene los brazos péndulos y las palmas juntas (a modo de rezo). Se debe observar la asimetría de los hemidorsos, con la presencia de giba/s. La maniobra es positiva cuando la giba está presente (Adams positivo) y negativa cuando está ausente (Adams negativo).